

*ТЗ с одним правильным ответом*

Химиотерапия туберкулеза - это {

~метод лечения туберкулеза с помощью различных химических веществ

~метод воздействия на возбудителя заболевания

=метод этиотропной терапии туберкулеза с помощью различных химических веществ

~ведущий метод лечения туберкулеза

}

Химиопрепараты –это {

~вещества, губительно влияющие на микобактерий туберкулеза

~различные бактерицидные и бактериостатические препараты

=вещества, специфически поражающие возбудитель заболевания, не оказывая существенного влияния на организм больного

~различные химические соединения, способствующие излечению больного туберкулезом

}

В понятие "фармакокинетика лекарственного препарата" входит все перечисленное, кроме {

~всасывания препарата из места введения

~распределения его по органам

~биотрансформации

~выделения

=воздействия на клетки и ткани

}

Основным принципом, на котором основана современная группировка противотуберкулезных препаратов, является {

~химическое строение препаратов

~эффективность препаратов

=величина минимальной тормозящей концентрации

~особенности фармакокинетики

}

Основной предпосылкой эффективности химиотерапии туберкулеза является {

~хорошая переносимость лечения

~высокий уровень защитных сил организма больного

=чувствительность микобактерий к применяемым препаратам

~хорошая или удовлетворительная фармакокинетика

}

Необходимость продолжительной химиотерапии при туберкулезе определяется в первую очередь {

~достигаемой при этом более высокой эффективности лечения

=медленными темпами инволюции туберкулезного процесса

~характером туберкулезного процесса

~целесообразностью максимально полного подавления микробной популяции

}

Оптимальная суточная доза химиопрепарата при лечении больного туберкулезом определяется всеми перечисленными факторами, кроме {

~переносимости химиотерапии

~фармакокинетики химиопрепарата

~массы тела больного и его возраста

~ритма введения химиопрепарата (ежедневно или прерывисто)

=необходимости достижения подавляющей рост микобактерий концентрации препарата в организме

}

Терапевтическая тактика при возникновении нежелательных побочных реакций в период химиотерапии определяется {

~степенью выраженности побочного свойства

~правильной идентификацией химиопрепарата, вызвавшего побочный эффект

=патогенезом выявляемых побочных реакций

~своевременным проведением корригирующих мероприятий

~комплексом корригирующих мероприятий

}

Патогенетическая терапия –это {

=терапия, воздействующая на состояние организма больного и происходящие в нем патологические процессы

~ терапия с применением противовоспалительных лекарств

~терапия с применением лекарственных средств, влияющих на иммунную систему

~терапия, направленная на улучшение переносимости химиопрепаратов

}

Иммуностимулирующую терапию целесообразно применять {

=в начале химиотерапии

~в середине химиотерапии

~в конце химиотерапии

~после окончания химиотерапии

}

Иммуностимулирующая терапия показана {

~при любой форме туберкулеза

~при замедленной положительной динамике процесса в ходе химиотерапии

=при снижении функции иммунной системы

~при плохой переносимости химиопрепаратов

}

Глюкокортикоидные гормоны показаны при всем перечисленном ниже, кроме{

~туберкулезного процесса, протекающего с преобладанием экссудативных реакций

~снижения функций коры надпочечников

~аллергических реакций на химиопрепараты

=отсутствия эффекта от химиотерапии

}

Глюкокортикоидные гормоны следует применять как противовоспалительное средство{

=с первых дней химиотерапии

~через 2-3 недели от начала химиотерапии

~при замедленной положительной динамике

~после снятия острых проявлений болезни

~после получения данных о чувствительности МВТ к химиопрепаратам

}

Глюкокортикоидные гормоны следует применять один раз в день{

=с 6 до 8 часов

~с 10 до 12 часов

~с 12 до 14 часов

~с 15 до 16 часов

~с 20 до 22 часов

}

Относительными противопоказаниями к назначению глюкокортикоидов являются все перечисленные, кроме {

~сахарного диабета

~гипертонической болезни I-II степени

~язвы желудка и 12-перстной кишки

~нарушения психики

=плохого сна

}

Методика лечения глюкокортикоидными гормонами зависит {

~от характера воспалительных реакций

=от показаний для назначения гормонов

~от возраста больного

~от наличия относительных противопоказаний

}

При туберкулезе с преобладанием экссудативного воспаления

глюкокортикоидную терапию следует назначить {

~с минимальной дозы и затем постепенно ее увеличивать

=с максимально показанной дозы и затем постепенно ее уменьшать

~со средней дозы и затем постепенно ее увеличивать

~с любой дозы

}

У больного 35 лет впервые обнаружен фиброзно-очаговый туберкулез легких в фазе инфильтрации, БК-. В течение длительного времени отмечается слабость, быстрая утомляемость. Артериальное давление - 90/60 мм рт. ст. Глюкокортикоидные гормоны можно применить {

~с противовоспалительной целью

=с заместительной целью

~для предупреждения побочных реакций на химиопрепараты  
~для повышения эффективности химиотерапии  
}

Нестероидные противовоспалительные препараты показаны {  
~при торпидном течении инфильтративного туберкулеза  
=при туберкулезе с преобладанием экссудативных реакций  
~при очаговом туберкулезе легких в фазе инфильтрации  
~при наличии полости распада  
~при плохой переносимости химиопрепаратов  
}

Биогенные стимуляторы следует применять {  
~в острой стадии заболевания  
=при торпидном течении туберкулеза  
~при туберкулезе с преобладанием  
экссудативного воспаления  
~при деструктивном туберкулезе  
}

При возникновении периферического полиневрита в результате химиотерапии наиболее целесообразно назначение {  
~тиамина  
~рибофлавина  
~никотинамида  
=пиридоксина  
~пантотеновой кислоты  
}

С целью устранения витаминной недостаточности и профилактики ее нарастания наиболее

целесообразно назначение {

~тиамина и рибофлавина

~никотинамида и пиридоксина

~пантотеновой кислоты и ретинола

~аскорбиновой кислоты и пиридоксина

=комплекса витаминов в сбалансированных соотношениях между ними

}

По механизму действия бронходилататоры делятся {

~на две группы

=на три группы

~на четыре группы

~на пять групп

}

Однократное внутривенное введение эуфиллина дает

бронхорасширительный эффект длительностью {

~до 2 часов

~до 4 часов

=до 6 часов

~до 8 часов

~до 12 часов

}

Горно-климатические курорты показаны больным {

~всеми формами туберкулеза легких в фазе инфильтрации

~всеми деструктивными формами туберкулеза легких

=ограниченными торпидно текущими формами туберкулеза легких

~всеми формами туберкулеза легких с признаками легочно-сердечной недостаточности

}

К методам коллапсотерапии легочного туберкулеза относят{

=лечебный пневмоторакс и пневмоперитонеум

~экстраплевральный пневмоторакс (пневмолиз)

~торакопластику

~лобэктомия

}

Длительность коллапсотерапии в эру химиотерапии туберкулеза обычно не превышает

~2 месяцев

=4-6 месяцев

~12 месяцев

~16-18 месяцев

}

Атипичная резекция легкого –это{

~удаление клиновидного участка легкого

~удаление края легочной ткани

~удаление краевого отдела легкого по плоскости

=удаление участка легкого без учета его анатомических границ

}

Предоперационная подготовка больных к операции удаления доли легкого при туберкулезе преследует цель{



=ограничить распространенность специфического процесса пределами удаляемой доли легкого и устранить признаки вспышки заболевания

~излечить инфекционный процесс и произвести операцию по поводу необратимых остаточных изменений (очаги осумкованного казеоза, цирроз, санированные каверны)

~достигнуть ремиссии процесса и прекращение бактериовыделения

}

Функциональная адаптация дыхания и гемодинамики у больного, перенесшего сегментарную резекцию легкого, обычно наступает в пределах {

~1 месяца после операции

=2-3 месяцев после операции

~3-4 месяцев после операции

~6 месяцев после операции

~10-12 месяцев после операции

}

Функциональная адаптация дыхания и гемодинамики у больного, перенесшего лобэктомию, обычно наступает в пределах {

~1 месяца после операции

~2-3 месяцев после операции

~3-4 месяцев после операции

=6 месяцев после операции

~10-12 месяцев после операции

}

Функциональная адаптация дыхания и гемодинамики у больного, перенесшего пневмонэктомию, обычно наступает в пределах {

~1 месяца после операции

~2-3 месяцев после операции

~3-4 месяцев после операции

=6 месяцев после операции

~10-12 месяцев и более после вмешательства

}

У больного 40 лет после 6 месячного лечения антимикобактериальными препаратами из инфильтративного туберкулеза в фазе распада сформировалась туберкулема во 2 сегменте правого легкого. Какой метод комплексного лечения показан пациенту? {

~продолжение химиотерапии до 10 месяцев

= хирургический

~ коллапсотерапия

~лазеротерапия

}

При лечении туберкулеза применяют: {

~левомицетин

= рифампицин

~пенициллин

~ тетрациклин

}

При лечении туберкулеза применяют: {

~ ампициллин,

~ фурадонин

= изониазид, рифампицин

~димедрол, баралгин

~преднизолон, циклофосфан

}

Основными противопоказаниями для назначения изониазида являются: {

=заболевания центральной и периферической нервной системы

~язвенная болезнь желудка

~сахарный диабет

~кохлеарный неврит

~холецистит

}

Согласно какому режиму химиотерапии получают лечение пациенты с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий? {

~ первому

~второму

~ третьему

=четвертому

}

К противотуберкулёзным препаратам первой группы (наиболее эффективным ) относятся: {

~стрептомицин + канамицин

~протионамид + ПАСК

~этамбутол + тизамид

=изониазид + рифампицин

~цикloserин + тибон

}

Основной курс лечения больных туберкулёзом составляет: {

~до 3-х месяцев

~2-4 месяца

=6-8 месяцев

~9-12 месяцев

~16-18 месяцев

}

Основным противопоказанием к назначению стрептомицина является: {

~язвенная болезнь желудка

~нарушение функции печени

=кохлеарный неврит

~сахарный диабет

~ катаракта

}

Комбинированная химиотерапия позволяет добиться длительной ремиссии процесса при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких с прекращением бактериовыделения {

~30-40% больных

= 50-60% больных

~70-80% больных

~ 85% и более больных

}

Несмотря на применение современных методов лечения,

прогрессирование туберкулеза у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких наблюдается {

- ~15-20% случаев
- ~24-30% случаев в.
- =35-40% случаев
- ~в 40-45% случаев

}

Специфическая химиотерапия у больных цирротическим туберкулезом показана во всех случаях, кроме: {

- ~при появлении признаков интоксикации
- ~при легочных геморрагиях
- =при дыхательной недостаточности
- ~при обострении специфического процесса, подтвержденного лабораторными методами исследования

}

В профилактике развития пневмоцирроза у больных туберкулезом в продуктивной фазе лечения заболевания рационально предусмотреть назначение {

- ~кортикостероидных гормонов
- ~изониазида и рифампицина
- ~антиоксидантов (тиосульфата натрия, токоферола и др.)
- =физиотерапии (ультразвук с лидазой)
- ~лазеротерапии

}

Применение химиопрепаратов при туберкулезе направлено на: {

- ~стимуляцию клеточного иммунитета
- = этиологический фактор

~подавление сапрофитной флоры

~ликвидацию интоксикации

}

Какое число противотуберкулезных препаратов должно быть включено в комбинацию для лечения вновь выявленного бацилярного больного с деструкциями в легких {

~не менее 2-х

~не менее 3-х

~не менее 4-х

= не менее 5-ти

}

Наиболее эффективный метод контроля за приемом химиопрепаратов больными туберкулезом в амбулаторных условиях: {

~выдача препаратов на руки больному не более чем на 5 - 7 дней

~контроль за приемом антибактериальных препаратов родственниками

= лабораторный контроль на присутствие препарата или его метаболитов в моче

~прием препаратов в присутствии медицинского работника (в диспансере, здравпункте, на ФАПе и т. д.)

}

Основное побочное действие рифампицина: {

~на центральную нервную систему

= гепатотропное

~на орган зрения

~снижение слуха

}

Основное побочное действие изониазида: {

= на периферическую нервную систему (невриты)

~ на слуховой нерв

~на почечный клиренс

~ на функцию щитовидной железы

}

Основное побочное действие этамбутола: {

~на периферическую нервную систему

~на желудочно-кишечный тракт

= на орган зрения

~на функцию почек

}

При каких формах туберкулезного процесса показано применение глюкокортикоидов? {

~очаговый туберкулез, легких в фазе рассасывания и уплотнения

~цирротический туберкулез легких

~туберкулема

=инфильтративный туберкулез

}

Одним из методов лечения туберкулемы является {

~метод предельных концентраций

=резекция легкого

~наложение искусственного пневмоторакса

~ наложение пневмоперитонеума

~дренирование плевральной полости

}

При подборе химиотерапии больному кавернозным туберкулезом необходимо учитывать, что {

~больной положительно реагирует на туберкулин

~больной имеет в крови повышенный уровень церулоплазмينا

~ больной имеет право на больничный лист

= больной скорее всего получал ранее туберкулостатики

~расположение каверны

}

При определении тактики лечения больного кавернозным туберкулезом необходимо решить, возможно ли применить {

= хирургические методы

~психотерапевтический метод

~первичную профилактику

~вакцинацию БЦЖ

~вакцинацию БЦЖ-М

}

Важнейшим методом лечения плевритов является {

~бронхоскопия

~ ирригоскопия

~метод предельных концентраций

= плевральная пункция

~ангиопульмонография



}

Если туберкулезный плевральный выпот большой, не рассасывается, поддерживает интоксикацию и одышку, то химиотерапию дополняют назначением {

= преднизолона

~туберкулина

~этазола

~вакцины БЦЖ-М

}

Наиболее эффективными противотуберкулезными препаратами считаются {

~ПАСК и тибон

~пиразинамид и этионамид

~ канамицин и этионамид

= изониазид и рифампицин

~тизамид и пиразинамид

}

Необходимость назначения трех и более туберкулостатиков при лечении туберкулеза обусловлена {

=быстрым развитием устойчивости к каждому из них

~низкой эффективностью каждого из них

~ особенностью отечественной фтизиатрической школы

~ сочетанием их побочных эффектов

~наличием сопутствующей неспецифической инфекции

}

Наиболее вероятным побочным эффектом при лечении этамбутолом может быть {

= снижение зрения

~снижения слуха и чувства равновесия

~снижение обоняния

~снижение интеллекта

~снижение желудочной секреции

}

Длительность непрерывного применения туберкулостатиков при лечении легочного туберкулеза не должна быть короче, чем {

~пять лет

~десять лет

= шесть месяцев

~ шестнадцать месяцев

~три года

}

Самым сильным противотуберкулезным антибиотиком является {

~стрептомицин

~канамицин

= рифампицин

~Флоримицин

~ПАСК

}

Среди перечисленных препаратов характеризуется гепатотоксическим эффектом {

~стрептомицин

~канамицин

= рифампицин

~Флоримицин

~ ПАСК

}

Основными критериями эффективного лечения туберкулеза органов дыхания принято считать {

~нормализацию СОЭ и церуллоплазмينا

= абацилирование и закрытие полостей

~исчезновение одышки и нормализацию температуры

~снятие туберкулезной интоксикации и прибавку в весе

~отсутствие побочных реакций на туберкулостатики

}

Показанием к хирургическому лечению туберкулеза считаются такие его формы, как {

~туберкулезный менингит и менингоэнцефалит

~облаковидный инфильтрат и перисциссурит

~острый и подострый диссеминированный туберкулез

= кавернозный туберкулез и туберкулемы

~ранняя и хроническая туберкулезная интоксикация

}

К иммуномодулирующим средствам при лечении туберкулеза относятся: {

~глюкокортикоиды

=препараты тимуса тималин, тактивин

~витамины группы В

~ацетилцистеин, химотрипсин

}

Наиболее часто рекомендуемый режим приема противотуберкулезных препаратов в амбулаторных условиях: {

~ежедневно суточная доза

~2 - 3 раза в день

= 3 раза в неделю

~2 раза в неделю

}

Критериями лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза (на плотной среде) служит для изониазида {

~20 мкг/мл

~10 мкг/мл

~5 мкг/мл

=1 мкг/мл

~0.1 мкг/мл

}

Для рифампицина критерий лекарственной устойчивости —это {

~100 мкг/мл

~50 мкг/мл

~30 мкг/мл

=20 мкг/мл

~10 мкг/мл

}

Для стрептомицина критерий лекарственной устойчивости –это {

~50 мкг/мл

~10 мкг/мл

=5 мкг/мл

~2 мкг/мл

~1 мкг/мл

}

Для этамбутола критерий лекарственной устойчивости –это {

~50 мкг/мл

~30 мкг/мл

~10 мкг/мл

~5 мкг/мл

=2 мкг/мл

}

Для канамицина критерий лекарственной устойчивости –это {

~50 мкг/мл

~30 мкг/мл

~20 мкг/мл

}

Какое число противотуберкулезных лекарственных средств включает режим  
лечения впервые выявленного пациента - бактериовыделителя при  
сохраненной чувствительности МБТ в интенсивной фазе? {

~2

~3

=4

~5–6

}

Рекомендуемая комбинация противотуберкулезных лекарственных средств в интенсивную фазу лечения ребенка с туберкулезной интоксикацией: {

~изониазид

~применение 5 АБП

~изониазид + этамбутол (или пиразинамид, протионамид)

=4. изониазид + рифампицин + пиразинамид + этамбутол.

}

Укажите число противотуберкулезных лекарственных средств, включаемых в режим терапии в фазе продолжения ранее леченого пациента (при сохраненной чувствительности МБТ)? {

~2

=3

~4

~5–6 и более

}

Срочным показанием для хирургического вмешательства при лечении туберкулеза легких является? {

~односторонний очаговый туберкулез в фазе распада;

= повторное кровохарканье, которое невозможно остановить другими методами;

~профузное легочное кровотечение;

~фиброзно-кавернозный туберкулез в верхней доле левого легкого

}

Что является неотложным показанием для хирургического вмешательства при лечении туберкулеза легких? {

~односторонний очаговый туберкулез в фазе распада

~повторное кровохарканье, которое невозможно остановить другими методами

~фиброзно-кавернозный туберкулез в верхней доле левого легкого

= профузное легочное кровотечение

}

К какой группе ПТЛС по классификации относятся фторхинолоны? {

~группа В

= группа А

~группа С

~ группа D

}

К какой группе по классификации относятся инъекционные ПТЛС 2-го ряда?  
{

~группа А

~ группа С

= группа В

~ группа D

}

Какой метод лечения следует предусмотреть при туберкулемах: {

~ глюкокортикоиды

~ анаболические стероиды

= хирургический

~ протеолитические ферменты

}

При каких формах туберкулезного процесса показано применение глюкокортикоидов? {

~очаговый туберкулез легких в фазе рассасывания и уплотнения;

~цирротический туберкулез легких;

~ туберкулема;

=милиарный туберкулез.

} Если туберкулезный плевральный выпот большой, не рассасывается, поддерживает интоксикацию и одышку, то химиотерапию дополняют назначением {

= преднизолона

~туберкулина

~этазола

~вакцины БЦЖ-М

}

Наиболее эффективными противотуберкулезными препаратами считаются {

~ПАСК и тибон

~пиразинамид и этионамид

~ канамицин и этионамид



= изониазид и рифампицин

~тизамид и пиразинамид

}

Необходимость назначения трех и более туберкулостатиков при лечении туберкулеза обусловлена {

=быстрым развитием устойчивости к каждому из них

~низкой эффективностью каждого из них

~ особенностью отечественной фтизиатрической школы

~ сочетанием их побочных эффектов

~наличием сопутствующей неспецифической инфекции

}

Наиболее вероятным побочным эффектом при лечении этамбутолом может быть {

= снижение зрения

~снижения слуха и чувства равновесия

~снижение обоняния

~снижение интеллекта

~снижение желудочной секреции

}

Длительность непрерывного применения туберкулостатиков при лечении легочного туберкулеза не должна быть короче, чем {

~пять лет

~десять лет

= шесть месяцев

~ шестнадцать месяцев

~три года

}

Самым сильным противотуберкулезным антибиотиком является {

~ streptomycin

~ kanamycin

= rifampicin

~ florimycin

~ PASK

}

Среди перечисленных препаратов характеризуется гепатотоксическим эффектом {

~ streptomycin

~ kanamycin

= rifampicin

~ florimycin

~ PASK

}

Основными критериями эффективного лечения туберкулеза органов дыхания принято считать {

~ normalization of CO<sub>2</sub> and ceruloplasmin

= abacilization and closure of cavities

~ disappearance of dyspnea and normalization of temperature

~ removal of tuberculous intoxication and weight gain

~ absence of side reactions to tuberculostatics

}

Показанием к хирургическому лечению туберкулеза считаются такие его

формы, как {

~туберкулезный менингит и менингоэнцефалит

~облаковидный инфильтрат и перисциссурит

~острый и подострый диссеминированный туберкулез

= кавернозный туберкулез и туберкулемы

~ранняя и хроническая туберкулезная интоксикация

}

К иммуномодулирующим средствам при лечении туберкулеза относятся: {

~глюкокортикоиды

=препараты тимуса тималин, тактивин

~витамины группы В

~ацетилцистеин, химотрипсин

}

Наиболее часто рекомендуемый режим приема противотуберкулезных

препаратов в амбулаторных условиях: {

~ежедневно суточная доза

~2 - 3 раза в день

= 3 раза в неделю

~2 раза в неделю

}

Критериями лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза (на плотной среде) служит для изониазида {

~20 мкг/мл

~10 мкг/мл

~5 мкг/мл

=1 мкг/мл

~0.1 мкг/мл

}

92

*ТЗ с выбором несколько правильных ответов*

Использование лечебного питания в комплексном лечении пациентов с туберкулезом направлено на:? {

~%33.33333%повышение защитных сил организма

~%33.33333%стимуляцию репаративных процессов

~%33.33333%нормализацию обменных процессов и восстановление нарушенных функций

~%-100%для нормализации сна

}

Хирургическая операция при цирротическом туберкулезе показана {

~%25%при одностороннем и относительно ограниченном поражении с бронхоэктазами

~%25%при частых обострениях неспецифической инфекции в зоне цирротических туберкулезных изменений у больных с односторонним поражением

~%25%у больных молодого и среднего возраста

~%25%при отсутствии тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности

~%-100%при наличии активного туберкулезного процесса

}

Основной причиной неудачи химиотерапии у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких является {

~наличие каверны с казеозным некрозом

~%50% наличие грубой фиброзной капсулы в стенке каверны

~%50%устойчивость микобактерий туберкулеза к лекарственным средствам  
и непереносимость их больными

~наличие очагов и участков инфильтрации

}

Составными элементами комплексного лечения туберкулеза являются: {

~%25% химиотерапия

~%25%патогенетическая терапия

~%25%коллапсотерапия

~%25%хирургическое лечение

~%-100% антибиотикотерапия

}

К нестероидным противовоспалительным препаратам следует отнести {

~%25%гепарин

~%25%бутадион

~%25%аминазин

~%25%тиосульфат натрия

~ %-100%рифампицин

}

Предупреждает избыточное развитие соединительной ткани при  
туберкулезном воспалении {

~%50% своевременное выявление заболевания

~%50%рациональная организация комплексного лечения туберкулеза, в том  
числе и средств

патогенетической терапии

~своевременная диагностика и устранение осложнений легочного  
туберкулеза и туберкулеза

внутригрудных лимфатических узлов

~распознавание и лечение сопутствующих заболеваний

}

При подготовке к оперативному вмешательству больному с цирротическим туберкулезом необходимо провести следующее исследование{

~%33.33333%ЭКГ

~%33.33333%ФВД

~%-100%УЗИ внутренних органов

~%33.33333%КТ легких

}

В комплекс лечебных мероприятий у больных туберкулезным экссудативным плевритом следует включать{

~%33.33333%этиотропные химиопрепараты

~%-100%сульфаниламиды

~%33.33333%противовоспалительные препараты

~%33.33333%плевральные пункции с эвакуацией экссудата

}